

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE

Técnicas de Contención y Cuidados de Enfermería en el Paciente con Alteración Psicomotora

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TENS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Contención en Psiquiatría
CURSO		N° ACTIVIDAD	2
ASIGNATURA		DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
1. Realizar los cuatro tipos de contención según norma técnica y bajo indicación médica en un escenario de simulación clínica controlada. 2. Aplicar cuidados de enfermería durante la contención de un paciente con alteración psicomotora en un ambiente simulado de baja fidelidad.			

3: INTRODUCCIÓN

La contención terapéutica constituye una intervención clínica utilizada para garantizar la seguridad de pacientes con alteraciones psicomotoras, del personal de salud y de terceros. Comprende medidas físicas, mecánicas, químicas y ambientales, siempre bajo estricta normativa técnica y autorización médica, priorizando en todo momento el respeto por la dignidad y derechos del paciente.

En Chile, según el último informe del Ministerio de Salud (MINSAL, 2023), los trastornos mentales y del comportamiento representan una de las principales causas de morbilidad, afectando al 16% de la población adulta. En servicios de urgencia, aproximadamente un 8% de las atenciones corresponden a situaciones de agitación o descompensación psicomotora. El uso de técnicas de contención en estos escenarios, cuando es apropiadamente indicado y ejecutado, se convierte en una medida crítica para la prevención de eventos adversos.

El impacto en la salud pública es significativo, ya que el manejo inadecuado de estos pacientes puede derivar en lesiones físicas, agravamiento de cuadros clínicos, judicialización de actos médicos y deterioro de la confianza en las instituciones de salud.

4: DESARROLLO DEL TEMA

La contención en el contexto psiquiátrico es una intervención compleja que combina habilidades técnicas, comunicacionales y éticas. Para comprender su aplicación, es necesario revisar su fundamento conceptual. Según la Norma General Técnica sobre Contención en Psiquiatría (MINSAL, 2003), el término “contener” alude al acto de recibir, acoger, proteger y cuidar al paciente. Esta definición es clave para comprender que la contención no es un acto coercitivo, sino una intervención terapéutica, que debe ser realizada por un equipo de salud capacitado, capaz de actuar con experticia técnica, sensibilidad interpersonal y juicio clínico frente a situaciones de crisis.

La contención en psiquiatría es definida como un proceso estructurado, en el cual el equipo de salud responde a manifestaciones de agitación psicomotora o crisis emocional, aplicando medidas que van desde la persuasión verbal hasta la intervención física, siempre con el objetivo de proteger al

paciente, a sí mismo y a terceros. Es fundamental comprender que existen cuatro tipos de contención, aplicables en orden progresivo, donde cada intervención se suma a la anterior:

Tipos de Contención

1. **Contención emocional o verbal:** Es la primera línea de intervención. Consiste en establecer un vínculo comunicacional con el paciente a través de una escucha activa, tono de voz calmado y uso de la persuasión, con el objetivo de tranquilizar y generar confianza. Se aplica en etapas iniciales de la agitación y, si se realiza correctamente, puede evitar la progresión hacia contenciones más invasivas.

- Palabras clave: escuchar, calmar, persuadir.



2. **Contención ambiental:** Comprende el manejo del entorno físico para reducir estímulos visuales, auditivos o sociales que puedan intensificar la agitación. Involucra la organización del espacio clínico, la remoción de objetos peligrosos y la regulación del ambiente, con el propósito de favorecer una respuesta más adaptativa del paciente.

- Palabras clave: aplacar, adaptar, proteger.



3. **Contención farmacológica:** Consiste en la administración de psicofármacos para reducir la sintomatología aguda, facilitando la estabilización del paciente. Siempre debe ir acompañada de comunicación verbal explicativa (en la medida que el estado de conciencia lo permita) y debe ser prescrita por un médico. En casos de negativa o resistencia, puede requerir sujeción temporal para permitir la administración.

- Palabras clave: explicar, aliviar, estabilizar.



4. **Contención física o mecánica:** Se aplica como último recurso, cuando el paciente representa un riesgo inminente de auto o heteroagresión. Consiste en la inmovilización parcial o total, utilizando dispositivos de sujeción (como fajas, muñequeras o correas). Esta medida debe ser aplicada por un equipo entrenado, durante el menor tiempo posible, con vigilancia continua y acompañada obligatoriamente de sedación farmacológica.
 - Palabras clave: proteger, limitar, supervisar.



Concepto de Crisis Psiquiátrica

Una crisis se define como un episodio transitorio en el que el paciente pierde el control de su conducta o de su situación emocional. Este estado puede desarrollarse de manera progresiva y suele manifestarse a través de signos sutiles: aumento en la inquietud motora, lenguaje hostil, mirada evasiva o amenazante, entre otros. Esta evolución se conoce como la escalada de agitación, y puede ser interceptada tempranamente si el equipo de salud es capaz de identificar estos signos.

La intervención debe seguir una secuencia escalonada:

1. Contención emocional
2. Contención emocional + ambiental
3. Contención emocional + ambiental + farmacológica
4. Contención emocional + ambiental + farmacológica + física

Incluso si es necesario aplicar medidas invasivas como la contención mecánica o la administración forzada de medicamentos, el equipo debe mantener la comunicación verbal constante, actuar con respeto y apegarse a protocolos éticos y legales.



Recurso Humano Mínimo Requerido para Contención Física

- Médico tratante o psiquiatra: indica y supervisa el procedimiento.
- Enfermero(a): lidera la intervención y administra la medicación.
- TENS o auxiliar clínico (x2): sujeción de extremidades superiores e inferiores.
- Personal adicional (si es necesario): sujeción de cabeza o asistencia en traslado.

Ejemplo Clínico Integrado: Caso Tulio

Tulio, paciente de 36 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, presenta un cuadro de agitación psicomotora progresiva. Rechaza alimentación, medicación y comienza a amenazar a otros pacientes. A pesar de la intervención verbal y ambiental, no responde a la contención inicial. El equipo ofrece fármacos vía oral, que también son rechazados. Finalmente, se realiza contención física asistida, permitiendo la administración intramuscular de antipsicóticos y el uso temporal de dispositivos de sujeción. La situación se controla progresivamente, destacando el uso de las cuatro técnicas de contención en orden creciente, con una actuación coordinada y ética por parte del equipo de salud.

Cuidados de Enfermería Durante la Contención

- Establecer vínculo con el paciente desde el inicio.
- Procurar un entorno seguro, retirando objetos peligrosos.
- Mantener informado al paciente de cada paso del procedimiento.
- Actuar con calma, rapidez y respeto; nunca desde la agresión.
- Verificar la correcta colocación de dispositivos de sujeción (sin comprometer circulación).
- Realizar controles de signos vitales periódicos.
- Supervisar continuamente la perfusión distal, estado de conciencia y estado emocional.
- Valorar la suspensión o mantención de la contención mecánica según evolución clínica.
- Registrar exhaustivamente cada acción realizada.

Conclusión

La contención en psiquiatría es una técnica compleja, que solo puede ser considerada terapéutica si se ejecuta con preparación, sensibilidad ética y enfoque interdisciplinario. La participación del Técnico en Enfermería es crucial para minimizar los riesgos físicos y psíquicos del paciente durante la crisis. Una ejecución profesional, humana y protocolizada transforma un procedimiento invasivo en una acción que salva y dignifica.

A continuación, dejamos un paso a paso sugerido para la contención.

Descripción	Justificación
Higiene de manos según norma MINSAL	Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
Presentarse con nombre y cargo al paciente	Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.

Evaluación Inicial del Paciente	Acción: Valorar el nivel de conciencia, el estado psicomotor, el riesgo de autolesión o agresión. Fundamento: Identificar la necesidad de intervención urgente y el tipo de contención más adecuada.
Aplicación de Contención Verbal (Relación de ayuda)	Acción: Utilizar comunicación calmada, lenguaje sencillo, establecer límites claros, contener emocionalmente. Fundamento: Es la primera medida terapéutica y menos invasiva. Puede evitar la progresión de la crisis.
Aplicación de Contención Ambiental	Acción: Modificar el entorno: bajar estímulos sonoros y luminosos, retirar objetos peligrosos, ubicar al paciente en un área segura. Fundamento: Disminuir estímulos externos reduce la sobrecarga sensorial y puede prevenir el agravamiento de la alteración psicomotora.
Solicitud y Verificación de la Indicación Médica	Acción: Confirmar indicación médica de contención farmacológica o mecánica, según necesidad. Fundamento: Asegurar respaldo ético y legal para continuar con intervenciones más restrictivas.
Administración de Contención Farmacológica (sólo con indicación médica)	Acción: Administrar medicamentos prescritos (sedantes, antipsicóticos, ansiolíticos) para controlar la agitación. Fundamento: Reducir la alteración psicomotora mediante el uso de fármacos, priorizando siempre la seguridad del paciente.
Preparación del Equipo de Salud y del Entorno	Acción: Organizar roles del equipo asistencial, preparar los dispositivos de sujeción si es necesario. Fundamento: Ejecutar la técnica de forma segura y ordenada, minimizando riesgos.
7. Explicación al Paciente (si es posible) y Consentimiento	Acción: Informar al paciente sobre la necesidad de la contención física/mecánica si la situación lo permite. Fundamento: Respetar la autonomía del paciente y fomentar la colaboración.
Aplicación de Contención Física Inicial	Acción: Sujetar cuidadosamente al paciente para controlar movimientos peligrosos durante la instalación de la sujeción mecánica. Fundamento: Prevenir autolesiones o daño a terceros de forma segura.
Instalación de la Contención Mecánica	Acción: Colocar dispositivos de sujeción en extremidades, ajustándolos correctamente (sin comprometer circulación). Fundamento: Inmovilizar al paciente de manera segura para evitar riesgos mayores.
Monitorización Continua	Acción: Evaluar signos vitales, perfusión, estado de conciencia y condiciones físicas cada 15 minutos o según protocolo. Fundamento: Detectar complicaciones o deterioro precozmente.
Reevaluación Periódica y Retiro de la Contención	Acción: Reevaluar periódicamente la necesidad de contención. Retirar progresivamente cuando la condición del paciente lo permita. Fundamento: Garantizar que la contención sea solo por el tiempo estrictamente necesario, respetando derechos humanos.
Registro Clínico Completo	Acción: Documentar detalladamente evaluación inicial, intervenciones realizadas, monitoreo y evolución del paciente. Fundamento: Dejar constancia legal y clínica de todas las acciones ejecutadas.

5: PAUTA DE COTEJO

CONDUCTA	SI	NO
El estudiante se presenta y saluda de manera respetuosa al paciente.		
Identifica correctamente al paciente por su nombre.		
Corroboró indicación médica antes de intervenir.		
Aplicó de forma adecuada la contención verbal como primera medida.		
Implementó estrategias de contención ambiental oportunamente.		
Solicitó/verificó indicación médica antes de proceder a contención farmacológica o mecánica.		
Administró medicamentos (farmacológicos) siguiendo indicaciones correctas (solo si corresponde en el escenario).		
Aplicó la contención mecánica de forma segura y respetuosa.		
Realizó monitorización continua adecuada del paciente.		
Demostró comunicación efectiva y contención emocional con el paciente.		
Trabajó en equipo respetando los roles asignados.		
Mantuvo una actitud profesional, ética y de respeto en todo momento.		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ✓ División de rectoría y regulación sanitaria. Norma general técnica sobre contención en Psiquiatría. 2003. Recuperado de http://ssmaule.redsalud.gob.cl/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3970&Itemid=187
- ✓ Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O'Higgins. Protocolo de Paciente Psiquiátrico con Episodio de Agitación Psicomotora en la Red Local de Urgencia (RLU) del Servicio de Salud O'Higgins (SSO). 2011. Recuperado de http://www.saludohiggins.cl/attachments/1080_P.%20Agitacion%20Psicomotara.pdf